



10/12/2020

קווים מנחים לביצוע ניתוחים קיסריים

מטרתו של מזכר זה הוא לנסות למנוע עד כמה שניתן סיבוכים לאחר ניתוח קיסרי וסיבוכים בניתוחים קיסריים חוזרים.

1. חתך בעור

במידה ומדובר בצלקת הפרטרופית בניתוח קיסרי חוזר מומלץ להוציא את הצלקת.

2. פתיחת שכבות הבטן

במידה ופתיחת הבטן נעשית ע"י דיאתרמיה, רצוי להשתמש כמה שניתן ב CUTTING ולא בקואגולציה.

3. ביקורת חלל הרחם

מומלץ שגם הרופא הבכיר בניתוח יבצע ביקורת חלל הרחם כדי למנוע שארית חומר הריוני.

4. צוואר הרחם

יש לוודא שצוואר הרחם פתוח לאחר הוצאת השיליה – ניתן להשתמש בהגרים להרחבת הצוואר במידת הצורך.

5. סגירת החתך ברחם

בניתוח קיסרי ראשון, סגירת דופן הרחם תבוצע בשתי שכבות.

6. מניעת הופעת דימום בזמן ולאחר הניתוח

לפני סגירת דופן הבטן יש לוודא שאין דימום מהחתך הניתוחי או בכל מקום אחר בבטן היולדת. מומלץ לוודא זאת כאשר לחץ דם הסיסטולי הוא מעל 90 (אפשר לבקש מהמרדים לדאוג לכך במידת הצורך). כמו כן יש לוודא שהרחם מכווץ עד לסיום הניתוח.

7. פריטונאום

בניתוח קיסרי ראשון מומלץ לסגור את הפריטונאום.

8. תת עור

יש לסגור את תת העור.

דר' רוני אברהמי, מנהל חדר לידה